Prématurité

Enjeux, impacts et accompagnement pluridisciplinaire

Dr NAGALO Kisito

Prof. Agrégé en pédiatrie UFR/SDS UJKZ

Pédiatre CHUP-CDG Ouagadougou

Pas de conflit d’intérêt

Plan

Introduction

- **Objectifs**
- **Données sur la prématurité**
- **Causes**
- **Conséquences**
- **Prise en charge**

Conclusion

Introduction

- Inquiétude des parents
- Préoccupation pour le pédiatre

"Petit guerrier" *(textes populaires)*

Tu es né un peu trop tôt,

Dans un monde un peu trop grand,

Mais ton cœur battait fort,

Comme celui des géants.

Branché, câblé, entouré,

Tu te bats sans dire un mot,

Chaque souffle est une victoire,

Chaque jour un cadeau.

Objectifs de la conférence

- Comprendre les enjeux de la prématurité
- Identifier les conséquences à court et long terme
- Souligner l'importance de l’accompagnement précoce et pluridisciplinaire

Données clés sur la prématurité

- **Définition** : naissance avant 37 SA ou 259ème jour de gestation
- **Contexte mondial**
  - Plus de 13 millions de bébés naissent prématurément chaque année, ce qui représente environ 10 % de toutes les naissances (OMS).
  - Inégalités : Les taux de prématurité varient selon les régions du monde (France, environ 8 %), plus grande incidence dans les pays à faible revenu

Données clés sur la prématurité

- Plus de 60 % # Part du total mondial des naissances prématurées survenant en Afrique et en Asie du Sud.
- Jusqu'à 16 % dans certains pays africains : Zimbabwé 16,4 %, Nigéria 19,9 %.
- **Contexte BF** : 17,9 % à 33,6 % ; mortalité 21 à 46 %

Données clés sur la prématurité

- **Problème de santé publique** :

  Journée mondiale de la prématurité (17 novembre)

  Thème 2024 « Défendre des soins de qualité pour chaque nouveau-né prématuré »

- **Intérêt pronostique**

- Fonctionnel : séquelles
- Vital : mortalité

Causes et facteurs de risque

- **Causes médicales** : infections, pré-éclampsie (13,5 %), anomalies placentaires (PPH 5 %)
- **Facteurs sociaux** : précarité, tabac, stress
- **Grossesses multiples** : BF 23,8 %, Algérie 2,2 %

Classification de la prématurité

- Modérée : 32-36 SA
- Grande prématurité : 28-31 SA
- Extrême prématurité : < 28 SA

Conséquences immédiates

- Détresse respiratoire : 2,6 % (MMH 1,6 %)
- Troubles thermiques
- Immaturité neurologique
- Troubles digestifs
- Troubles hématologiques (hémorragies) : 42 %

Conséquences à long terme

- Troubles moteurs (hypotonie, paralysie cérébrale)
- Retards cognitifs, langagiers et sensoriels
- Difficultés d’apprentissage

Parcours d’un enfant prématuré

Soins en néonatalogie

Objectif principal : assurer la **survie**, le **développement** et le **confort** des nouveau-nés nécessitant une surveillance ou une assistance médicale.

Il s’agit :

- Stabiliser les fonctions vitales de l’enfant
- Prévenir et traiter les complications médicales
- Assurer un environnement adapté au développement neuro-sensoriel
- Soutenir le lien parents-enfant
- Préparer le retour à domicile en toute sécurité

Types de soins

Catégorie	Soins associés
Fonction respiratoire	Ventilation assistée (CPAP, intubation), oxygénothérapie, surveillance de la saturation, kinésithérapie respiratoire
🍼 **Alimentation et digestion**	Nutrition parentérale, gavage (sonde naso-gastrique), allaitement maternel encouragé, aide à la succion-déglutition
🌡️ **Régulation thermique**	Incubateur, humidification, couverture chauffante, peau à peau
❤️ **Surveillance hémodynamique**	Monitorage du rythme cardiaque, tension artérielle, perfusions, transfusions
🧪 **Suivi biologique**	Prises de sang régulières, suivi des électrolytes, hémogrammes, marqueurs d'infection
💊 **Traitements médicaux**	Antibiotiques, corticoïdes, caféine, surfactant, supplémentation en fer, vitamines
🧴 **Soins essentiels**	Toilette, changes, soins de peau (prévention des lésions), positionnement
👀 **Développement neuro-sensoriel**	Soins de développement, réduction des stimulations nocives (bruit, lumière), bercement, posture contenante (cocon)
👩‍👶 **Soutien au lien affectif**	SMK, accompagnement à la parentalité, présence des parents encouragée 24h/24

Suivi post-néonatal

- Rôle **fondamental** dans la détection précoce des troubles du développement, la prévention des complications, le soutien aux familles et l'accompagnement vers une santé optimale.
- **But du suivi post-natal du prématuré**

- Surveiller la croissance staturo-pondérale et cérébrale
- Détecter précocement les troubles
- Prévenir et prendre en charge les complications
- Soutenir le développement global de l'enfant (moteur, cognitif, relationnel)
- Accompagner les familles dans le parcours de soins
- Assurer une transition coordonnée entre l'hôpital, la ville et les structures de rééducation/soutien précoce

Suivi de de croissance

- Poids, taille, PC
- Apports nutritionnels

Surveillance neurologique et développementatale

- Examen neurologique
- Tests de développement

Dépistages sensoriels

- Audition, vision

Surveillance médicale globale

- Respiratoire, digestif
- Métabolique, cardiaque

Soutien psychomoteur et psycho-affectif

- Kinésithéraple, psychomotricité
- Stimulation motrice

Soutien psychomoteur et rééducation précoce

Kinésithérapie, psychomotricite

- Stimulation motrice

Coordination du parcours de soins

- Consultation en reseau, CAMSP
- Plan personnalisé de suivi

1. Suivi de la croissance

Eléments	Modalités
Poids, taille, périmètre crânien	Mesures régulières, courbes de croissance spécifiques (OMS)
Apports nutritionnels	Vérification du bon apport calorique et protéique
Suivi du transit	Tolérance digestive, reflux, constipation

2. Surveillance neurologique et développementale

Eléments	Objectifs
Examen neurologique régulier	Repérer des signes précoces de paralysie cérébrale, anomalies du tonus ou des réflexes
Tests de développement	Echelles standardisées : AIMS, Denver II, Brunet-Lézine, Bayley selon les âges
Suivi du tonus, posture, coordination	Dépistage des troubles neuromoteurs, troubles de la latéralisation

3. Dépistages sensoriels

Sens	Examens
👂 Audition	Otoémissions acoustiques, PEA si doute
👁️ Vision	Dépistage de la rétinopathie du prématuré (ROP), suivi ophtalmologique prolongé si besoin

4. Surveillance médicale globale

Points	Détails
Respiratoire	Suivi de la dysplasie bronchopulmonaire, des infections respiratoires
Digestif	Contrôle du RGO, de l'alimentation orale
Cardiaque	Persistance du canal artériel, HTAP (écho de contrôle)
Métabolique	Surveillance de l’anémie, rachitisme, carences (fer, vitamine D)

5. Soutien psychomoteur et rééducation précoce

- Interventions par **kinésithérapeutes**, **psychomotriciens**, **orthophonistes**
- Stimulation motrice douce, prévention des attitudes vicieuses
- Soutien à l’oralité (succion, mastication)
- Favoriser la motricité libre, le jeu, l’interaction

6. Accompagnement parental et psycho-affectif

- Education thérapeutique : alimentation, positionnement, sommeil
- Soutien psychologique des parents
- Valorisation du rôle parental
- Orientation vers les associations de parents (SOS Préma, etc.)

7. Coordination du parcours de soins

- Consultation dans des **réseaux de suivi du prématuré**
- Travail en lien avec la médecine de ville, la SMI, la crèche
- Rédaction d’un **plan personnalisé de suivi**

Calendrier typique des consultations

Age corrigé	Visite de suivi
A la sortie de néonat	Bilan initial avec lettre de liaison
1 mois	Bilan croissance, tonus, alimentation
3, 6, 9 mois	Evaluation développementale, tonus, interactions
1 an	Bilan global sensoriel, moteur et cognitif
2 ans	Bilan orthophonique et psychomoteur possible
Jusqu'à 6-7 ans	Suivi scolaire, attentionnel, social

Rôle du kinésithérapeute

❑**Son intervention** vise à soutenir le développement neuro-moteur, prévenir les complications secondaires et accompagner l'enfant et sa famille tout au long de son parcours de soins.

❑**Objectifs principaux de l'intervention du kinésithérapeute**

•Prévention des complications posturales et orthopédiques

•Stimulation du développement moteur harmonieux

•Accompagnement à l'oralité et à la respiration

•Soutien au lien parent-enfant et à la parentalité

•Participation au suivi interdisciplinaire du développement

Rôle du kinésithérapeute

🧠 Prévention des complications posturales et orthopédiques

🚼 Stimulation douce du développement moteur (mobilisations, positionnements)

🫁 Aide à la respiration (positionnement, éducation respiratoire/ cas)

👄 Participation à la PEC de l'oralité (succion, déglutition, alimentation)

🧸 Soutien à l'éveil sensoriel et moteur (jeu, coordination, tonus)

👨‍👩‍👧 Guidance parentale : portage, motricité libre, bain, respect du rythme

🤝 Travail en équipe pluridisciplinaire

📈 Suivi ambulatoire post-natal du développement moteur

Prises en charge motrices précoces

- **But** : soutenir le développement global de l'enfant en agissant sur l'articulation entre le **corps**, le **mouvement**, les **émotions** et la **relation à l'environnement**.
- Adaptées aux besoins particuliers des bébés nés avant terme, souvent exposés à des fragilités sensori-motrices, relationnelles ou posturales.

Prises en charge motrices précoces

- **Objectifs principaux**

- Favoriser le **développement harmonieux** des compétences motrices, sensorielles et émotionnelles.
- Prévenir l'apparition de **troubles du tonus**, de la posture, de la coordination.
- Soutenir la **relation parent-enfant**, souvent fragilisée par l'hospitalisation précoce.
- Encourager l'**exploration**, la **conscience corporelle** et la **régulation émotionnelle**

Approche interdisciplinaire

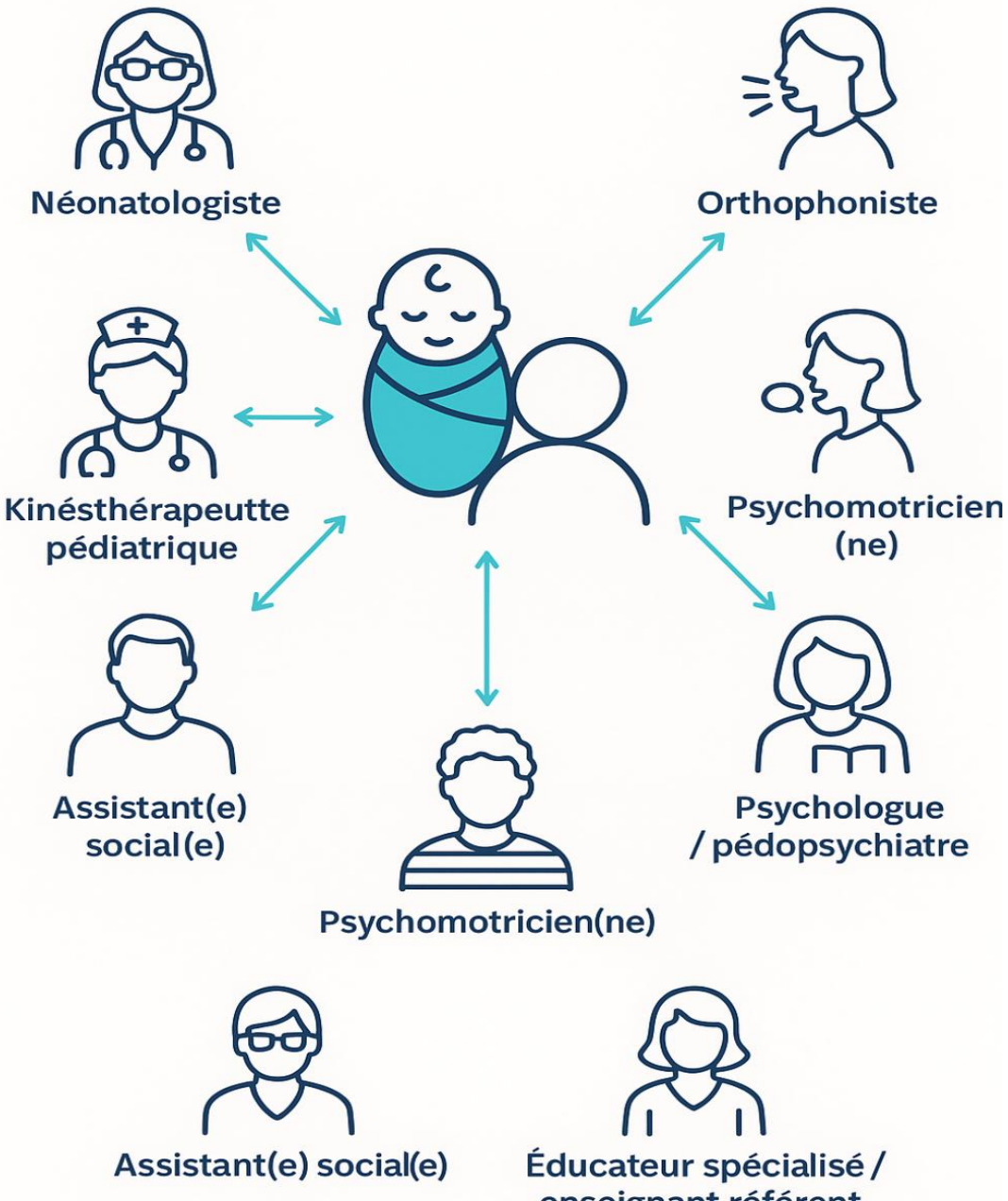
Collaboration cliniciens, orthophonistes, psychomotriciens

- Réunions régulières : staffs, bilans de suivi pour partager les observations et coordonner les interventions.
- Plan personnalisé de soins : Adapté à l'évolution de l'enfant.
- Partage d'information : Carnet de liaison, dossiers partagés.
- Place centrale des parents : écoute, guidance, valorisation de leurs compétences

Les principaux intervenants et leurs rôles

Profession	Rôle dans la prise en charge de l'enfant prématuré
Néonatologiste	Supervise les soins médicaux initiaux, gère les complications
Infirmier(ère) en néonatalogie	Apporte les soins quotidiens, surveille l'évolution clinique
Kinésithérapeute pédiatrique	Evalue et stimule le développement moteur, accompagne les parents
Psychomotricien(ne)	Soutient l'intégration sensori-motrice et la coordination
Orthophoniste	Evalue la succion, la déglutition et le langage si besoin
Psychologue / pédopsychiatre	Soutient le lien parent-enfant, aide à gérer le stress parental
Assistant(e) social(e)	Aide à l'accès aux ressources et soutient l'inclusion sociale
Éducateur spécialisé / enseignant référent	Favorise l'intégration à la crèche ou à l'école

Approche interdisciplinaire



Conclusion

1. La prématurité a des impacts durables
2. L’intervention précoce est essentielle
3. Prise en charge multidisciplinaire
4. Réseautage
5. Stratégie de prévention : surveillance de la grossesse (collaboration obstétrico-pédiatrique)

"Prématuré, mais parfait" *(inspiré de recueils anglophones)*

Tu n’étais pas attendu si tôt,

Mais ton cœur battait déjà fort,

Chaque battement disait : « Je suis là »

Et chaque souffle, un trésor.

Prématuré, mais parfait,

Un miracle entre mes bras,

Un héros minuscule

Qui fait de moi un parent roi.

Grandes personnalités nées prématurées

1. **Winston Churchill** : Homme d'État britannique, Premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale. Né environ 2 mois avant terme.
2. **Albert Einstein** : Physicien célèbre pour la théorie de la relativité. Né prématuré et fragile, selon des témoignages biographiques.
3. **Mark Twain** : Auteur américain de Tom Sawyer. Né prématurément avec peu d'espoir de survie.
4. **Stevie Wonder** : Musicien et chanteur américain, né 6 semaines en avance.

Grandes personnalités nées prématurées

5. **Victor Hugo** : Poète et écrivain français. décrit comme chétif à la naissance
6. **Pablo Picasso** : Artiste et pionnier du cubisme. Né prématurément avec des difficultés respiratoires.
7. **Voltaire :** Philosophe et écrivain français des Lumières, connu pour son esprit satirique et son combat pour la tolérance et la liberté de pensée.
8. **Charles de Gaulle :** Général, résistant, homme d'État et écrivain français, deux fois président de la République.
9. **Charles Darwin :** Naturaliste britannique, célèbre pour sa théorie de l'évolution.

Merci pour votre aimable attention